

奥氮平与其它药物相互作用的概述

陈福新 赵仁珍

【中图分类号】 R749.053

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-3256 (2010) 03-0192-04

奥氮平作为非典型抗精神病药,能显著改善精神分裂症患者的阴性、阳性症状及情感症状,由于疗效佳,锥体外系不良反应少见,患者易于接受,目前已广泛用于精神病的急性期和维持治疗,亦可缓解精神分裂症及相关疾病常见的继发性情感症状。随着临床使用的增加,现将奥氮平与其他药物相互作用概述如下:

1 奥氮平的药动学性质

奥氮平口服吸收良好,不受进食影响,有首过消除,血浆蛋白结合率为 93%。在 1~20mg 剂量范围内,奥氮平的血浆浓度与剂量成比例地线性上升。口服后 5~8 小时血药浓度达峰,平均半衰期为 33 小时。性别、年龄和吸烟状况对奥氮平的半衰期和清除率有一定影响,女性长于男性,正常老年人 (≥ 65 岁) 半衰期延长,但影响幅度与个体间的整体变异相比并不大。药物在体内主要经肝脏代谢,其代谢产物无法透过血脑屏障,在肝脏经肝药酶 CYP1A2 和 CYP2D6 代谢、次要经 3A4 酶代谢,形成无活性的 10-N-葡萄糖醛酸和 N-去甲基奥氮平。约 75% 奥氮平主要以代谢物的形式从尿中排出,30% 从粪便排出。在联合用药治疗时,诱导奥氮平代谢酶活性的药物可降低其效价,而抑制这些酶活性的药物则可增加其不良反应。

2 与情绪稳定剂的相互作用

2.1 联用碳酸锂 邓氏等^[1]将 66 例双相情感障碍躁狂发作患者随机分为两组,使用碳酸锂治疗,分别合用奥氮平或利培酮治疗 6 周,采用 Beck-Rafaelsen 躁狂量表 (BRMS)、大体评定量表 (GAS)、疗效总评量表、病情严重程度 (CGI-SI)、副反应量表 (TESS) 进行评定,结果奥氮平组与利培酮组疗效相当,奥氮平组主要药物不良反应有体重增加、空腹血糖异常等。

2.2 联用丙戊酸类药物 安氏等^[2]将 62 例躁狂症病人随

机分为奥氮平联用丙戊酸钠组 42 例和碳酸锂组 20 例,采用 BRMS、TESS 分别于治疗前、治疗 1、2、4、6 周进行评定,结果显示,联用时二者剂量均明显降低,疗效肯定,起效快,不良反应轻,缩短住院时间,提高了依从性。李氏等^[3]将 40 例急性期精神分裂症患者随机分为奥氮平联用丙戊酸镁组与奥氮平组,疗程 2 周,分别于治疗前、治疗第 1、2 周末采用 PANSS 减分情况评定疗效,结果显示,奥氮平合并小剂量丙戊酸镁缓释片能更快、更有效地控制急性期精神分裂症的兴奋激越症状。不过,二者联用有可能出现体重增加和过度镇静等不良反应增加^[4],安氏等^[2]的研究中 15 例 (35.7%) 出现嗜睡,12 例 (28.6%) 体质量增加。

2.3 联用卡马西平 卡马西平系细胞色素 P450 酶诱导剂,两者合用会降低奥氮平的血药浓度,停用后奥氮平血药浓度可上升,当停用卡马西平时,最好要注意监测奥氮平的血药浓度。来自病例报告和健康志愿受试者的药代动力学研究和患者治疗药物监测数据的证据表明:卡马西平最有可能通过对 CYP1A2 的诱导,刺激奥氮平的生物转化,因而降低奥氮平的血药浓度。在一项 11 例健康自愿受试者的研究中,联合奥氮平和卡马西平,导致奥氮平的消除率增加 46%;在患者中,合用卡马西平和标准剂量的奥氮平后,奥氮平的血药浓度低于奥氮平单一治疗的 36%~71%。在联合卡马西平时,奥氮平的剂量需调整^[5]。

3 与抗抑郁药物的相互作用

3.1 联用氟西汀 刘氏等^[6]将阴性症状为主的精神分裂症患者,随机分为奥氮平合用氟西汀组 32 例和单用奥氮平组 30 例,两组采用 PANSS 减分率评定疗效,TESS 评定药物不良反应,共观察 8 周。结果显示:奥氮平合用氟西汀组与单用奥氮平组治疗精神分裂症的有效率为 90.63% 和 73.33% ($P>0.05$),显效率为 75.00% 和 40.00% ($P<0.01$); PANSS 总分、减分及阴性因子减分在第 2、4、8 周末奥氮平合用氟西汀组均优于单用奥氮平组 ($P<0.05$ 或 0.01); 两组药物的不良反应少,奥氮平合用氟西汀组的体重增加明显低于单

作者单位: 671000 云南省大理州第二人民医院

用奥氮平组 ($P < 0.05$)。作者认为,奥氮平联合氟西汀治疗能明显改善精神分裂症的阴性症状,且安全性好。

王氏等^[7]将 74 例难治性抑郁症患者随机分为 2 组,研究组氟西汀 (20mg/d) 合并奥氮平 (5~10mg/d), 对照组仅用氟西汀 (20mg/d) 治疗, 两组持续治疗观察 4 周, 于入组前及入组后第 1、2、4 周末分别用汉密尔顿抑郁量表 (HAMD)、汉密尔顿焦虑量表 (HAMA) 及不良反应量表 (TESS) 进行评定。结果两组在治疗后第 2、4 周末, HAMD、HAMA 总分及减分率的差异有统计学意义, 两组间有效率的差异也有统计学意义。研究组和对照组分别有 48.5% 和 38.9% 出现不良反应, 差异无统计学意义。结论为小剂量奥氮平在难治性抑郁症的治疗中有增效作用, 优于单用氟西汀, 且安全性较好, 在临床上可作为治疗难治性抑郁症的一个备选方案。李鹤展等^[8]采用双盲对照研究, 将 52 例诊断为难治性抑郁症的患者随机分为两组, 一组采用氟西汀治疗, 一组采用氟西汀合并奥氮平治疗, 分别在治疗后第 2、4、6、8 周末, 分别采用 HAMD、临床总体印象量表 (CGI) 及 Asberg 抗抑郁剂不良反应量表进行评定。结果显示氟西汀联合奥氮平治疗难治性抑郁症的疗效要明显优于单用氟西汀 ($P < 0.05$), 药物不良反应两组间差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。作者认为氟西汀联合奥氮平治疗难治性抑郁症的疗效要明显优于单用氟西汀 ($P < 0.05$), 药物不良反应两组间差异则无统计学意义 ($P > 0.05$)。

马氏等^[9]将符合 CCMD-3 诊断标准的 44 例抑郁症随机分为两组, 研究组给予氟西汀联合奥氮平, 对照组单用氟西汀, 氟西汀剂量为 20mg/d 奥氮平为 25mg/d 疗程 6 周。采用汉密尔顿抑郁量表 (HAMD)、TESS 评定疗效及不良反应。经 6 周治疗后, 研究组显效率为 86.4%, 对照组为 59.1%, 两组相比, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 两组间 HAMD 减分率于第 2、4、6 周末比较差异有统计学意义 ($P < 0.05 \sim 0.01$), TESS 各周差异则无统计学意义 ($P > 0.05$), 研究组优于对照组, 且不增加不良反应。

3.2 联用帕罗西汀 刘氏等^[10]将 70 例抑郁症患者随机分为帕罗西汀组 (单用组) 和帕罗西汀合用奥氮平组 (合用组)。共观察 8 周, 于治疗前, 治疗后 1、2、4、6、8 周末采用 HAMD、TESS 评定疗效及不良反应, 并随访 1 年, 观察其 1 年内的复发率。研究显示, 帕罗西汀合用小剂量奥氮平治疗抑郁症起效快, 克服了抗抑郁药本身起效慢的弱点, 可提高疗效, 并能迅速改善睡眠障碍和焦虑 躯体化症状, 对复发率无明显影响。刘氏等^[11]的研究亦支持上述结论, 但联用组体重增加、嗜睡、头晕明显高于单用组, 差异有统计学意义。

3.3 联用西酞普兰 李氏等^[12]将 67 例患者随机分为单用西酞普兰组和西酞普兰合并奥氮平组, 并进行 3 个月的治

疗, 采用 HAMD、TESS 和自编躯体症状调查表等进行测评。结果在抑郁症状缓解方面两组均显效; 对于躯体症状的改善, 合用组优于单用组, 两组不良反应均较小。结论为西酞普兰合并奥氮平在治疗伴躯体障碍抑郁症方面效果优于单用西酞普兰。

3.4 联用舍曲林 余氏^[13]将 68 例难治性抑郁症患者随机分为研究组 (奥氮平联合舍曲林 34 例) 和对照组 (单用舍曲林 34 例), 疗程 8 周。以 HAMD 及 TESS 分别在治疗前及治疗第 1、2、4、6 和 8 周末各评定 1 次, 以生活质量综合问卷 (GQOLI-74) 在治疗前和治疗后 8 周末各评定一次生活质量。结果研究组于第 1 周末起效, 对照组于第 2 周末起效, 治疗后 1、2、4、6、8 周末 HAMD 评分差异有统计学意义 ($P < 0.01$)。两组间 TESS 评分差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。8 周末, 研究组除物质生活维度外, 其他维度得分明显高于对照组, 差异有统计学意义 ($P < 0.01$)。结论奥氮平辅助治疗难治性抑郁症起效快, 可增加疗效, 优于单用舍曲林治疗, 且明显改善患者的生活质量。

3.5 氟伏沙明 氟伏沙明是一种 P450-1A2 强抑制剂, 可显著抑制奥氮平的代谢。王氏等^[14]对 12 名男性健康志愿者, 采用自身前后对照设计, 两次服药间隔 4 周, 口服单剂奥氮平 10mg 对照部分采用单剂量奥氮平, 试验部分是在氟伏沙明连续 9 天服用过程中的第 4 天合用单剂量奥氮平。高效液相色谱电化学法测定奥氮平血浆浓度。结果显示, 合用氟伏沙明后, 奥氮平各时点的平均浓度增高; 峰浓度由 19.5 μ g/L 增至 29.1 μ g/L (1.52 倍, $P < 0.001$), 消除半衰期由 32.2h 延长为 46.1h (1.48 倍, $P < 0.01$), 0~120h 药时曲线下面积增加; 而达峰时间由 3.8h 缩短为 2.6h (0.69 倍, $P < 0.01$), 系统清除率由 16.4L/h 减至 8.5L/h (0.59 倍, $P < 0.001$), 表观分布容积由 435.5L 降为 299.2L (0.70 倍, $P < 0.01$)。结论为氟伏沙明能明显抑制奥氮平在体内的代谢。CYP1A2 可能是催化奥氮平体内代谢的主要氧化酶之一。奥氮平与涉及 CYP1A2 的药物合用时应注意密切观察、趋利避害。

4 与其它抗精神病药的相互作用

4.1 联用五氟利多 俞氏等^[15]对 82 例患者进行了为期 24 周的奥氮平联合五氟利多 (实验组) 与单用奥氮平 (对照组) 的随机临床疗效对照观察。结果显示, 奥氮平联合五氟利多与单用奥氮平治疗疗效相当, 但实验组有节省治疗费用的明显优势, 值得临床使用。

4.2 联用舒必利 郭氏等^[16]对 97 例难治性精神分裂症患者随机分为三组, 分别用舒必利、奥氮平、舒必利合并奥氮平治疗 6 个月, 在治疗前及治疗后 2、4、6 个月用 BPRS、SANS、

CGI量表评定疗效。研究结果显示三种方法治疗难治性精神分裂症 6 个月后均有效,舒必利合并奥氮平较单一用药更有效,不良反应少。

4.3 联用利培酮 至今尚未见有关奥氮平与利培酮联用的随机研究报道,仅有 Lemer等^[17]的一项初步开放性病例系列研究。此研究包括 5 例住院患者,按 DSM-IV 标准^[18]诊断为精神分裂症或分裂样情感性精神病。在联合用药之前所有患者均接受过 2~4 种典型抗精神病药物与非典型抗精神病药物(氯氮平)治疗,效果均不佳。接着以奥氮平或利培酮替换单独治疗,效果仍不好。研究中患者接受了奥氮平或利培酮交叉联合治疗,患者联合奥氮平剂量为 10~15mg/d 利培酮 1~5mg/d 研究期间进行了血常规监测,并用 BPRS 对合用前及合用后疗效进行了评估,评定标准为:即 BPRS 评分降低 25% 以上,患者临床症状为改善。结果所有患者的阳性症状及 1 例患者的阴性症状均得到改善。5 例患者 BPRS 平均降低 23.8 分 (30%),其中有 2 例症状改善明显 (BPRS 评分分别降低 31%、38%),另 3 例临床症状改善 (BPRS 评分分别 25%、27% 及 29%)。研究期间血常规未发生变化,也未见不良反应发生。此研究结果支持奥氮平与利培酮联用,本研究缺陷在于入组人数太少,无对照组,因而影响了证据的可靠性。

4.4 联用其它典型抗精神病药物 关于奥氮平与其他典型抗精神病药物的联用,至今未见有随机对照试验的报道。Mazeh^[19]等报道一个由 3 例患者参加的开放性试验,试验前后以 CGI 量表进行评估。受试者开始单用奥氮平 20mg/d 症状均有部分好转,3 例患者 CGI 评分分别下降 1 分、2 分、1 分。接着研究者根据患者病情分别联用了 3 种典型抗精神病药物共 12 周。结果 3 例患者 CGI 均降低 1 分,阳性症状有明显改善;第 1 例联用珠氯噻醇 (60mg/d) 焦虑症状缓解;第 2 例联用氟哌啶醇 (15mg/d) 偏执想法消失;第 3 例联用奋乃静 (16mg/d) 偏执妄想逐渐消失,未见不良反应报道。以上试验及报道表明,对奥氮平治疗无反应或有部分反应的患者经与典型抗精神病药物联合应用后,可增强治疗效果。

5 与其它药物的相互作用

5.1 联用抗菌素

5.1.1 联用红霉素 奥氮平主要经 3A4 酶代谢,红霉素重度抑制 3A4 酶,理论上增加奥氮平血浓度。实际上,红霉素与奥氮平的相互作用自相矛盾。病例报告表明,服红霉素增加氯氮平血浓度,且伴有中毒效应。但健康受试者服红霉素,不影响奥氮平血浓度。

5.1.2 联用环丙沙星 奥氮平主要经 1A2 酶代谢,抗菌素环丙沙星抑制 1A2 酶,从而抑制奥氮平代谢,增加奥氮平血

浓度。尽管环丙沙星能减少奥氮平的剂量,节约奥氮平的费用,但长期用环丙沙星可引起二重感染,故不能长期联用。

5.2 与 H₂受体阻断剂

5.2.1 联用雷尼替丁 孙氏等^[20]将 68 例首发精神分裂症患者随机分为研究组 (35 例) 和对照组 (33 例),在奥氮平单药治疗的基础上,研究组合并雷尼替丁,对照组合并安慰剂,疗程 10 周;于治疗前及治疗后 2、4、6、8、10 周测定体重、体质指数 (BMI)、腰围、腰臀比等体重指标;治疗前及治疗 10 周后测定空腹血糖,并采用阳性和阴性症状量表 (PANSS) 及不良反应量表 (TESS) 进行评定。结果两组治疗 10 周后 BMI、腰围、腰臀比及体重变化的差异有统计学意义 ($P < 0.01$);其中研究组治疗 6~8 周及 8~10 周期间体重变化明显低于对照组 ($P < 0.001$);两组治疗后血糖均显著高于治疗前 ($P < 0.05$),但尚在正常范围;两组间 PANSS 减分率、TESS 评分差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。初步结论为雷尼替丁可早期预防抗精神病药物奥氮平所致的体重增加,且不影响抗精神病治疗的疗效及耐受性。

5.2.2 联用西咪替丁 有关奥氮平联用西咪替丁的相关资料较少,奥氮平主要经 3A4 酶代谢,西咪替丁抑制 3A4 酶,理论上抑制奥氮平代谢,增加其血药浓度,因此,联用时要注意监测奥氮平的血浓度,适当减少奥氮平的剂量。

5.3 联用苯二氮䓬类

5.3.1 联用地西泮 奥氮平主要经葡萄糖醛酸结合代谢,地西泮抑制尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶,理应抑制奥氮平代谢,增加奥氮平血浓度,但试验证明,地西泮不影响奥氮平血浓度。

5.3.2 联用氯硝西泮 张氏^[21]将 65 例精神分裂症急性期兴奋患者,随机分为口服奥氮平合并肌内注射氯硝西泮组 34 例和肌内注射氟哌啶醇 31 例,疗程 7 天,以阳性与阴性症状量表兴奋激越项目和 TESS 评定疗效和不良反应,结果显示奥氮平合并氯硝西泮可有效治疗精神分裂症急性期精神运动性兴奋,疗效与氟哌啶醇相当,不良反应明显少于氟哌啶醇。

5.3.3 联用唑仑类 三唑仑和咪达唑仑完全经 3A4 酶代谢,阿普唑仑主要经 3A4 酶代谢,奥氮平次要经 3A4 酶代谢,联用时影响奥氮平的代谢,可能会加重过度镇静作用。

5.4 吸烟 奥氮平的代谢受肝药酶细胞色素 P450 诱导剂的影响,特别是 CYP1A2 的活性,吸烟能诱导 CYP1A2 的活性,可增加奥氮平的清除率。非吸烟者与吸烟者相比,奥氮平的清除率下降 33%,消除相末端半衰期延长 21%。

5.5 酒精 奥氮平经过 1A2、2D6、3A4、2C19、2C9 酶和尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢。唯独不经 2E1 酶代谢,酒精仅诱导肝脏 2E1 酶,故不影响奥氮平血浓度。

参 考 文 献

1 邓文,徐彩霞,马崇玉,等.新型抗精神病药对躁狂发作的辅助治疗[J].临床精神医学杂志,2005,15(2):90~91.

2 安红伟,王翠敏,李占胜,等.奥氮平联用丙戊酸钠治疗躁狂发作对照研究[J].临床精神医学杂志,2008,18(5):349.

3 李万顺,于晓东,崔宇.奥氮平合并丙戊酸镁缓释片治疗急性期精神分裂症的对照研究[J].精神医学杂志,2008,21(3):178~179.

4 陈福新.丙戊酸类药物相互作用[J].中国执业药师杂志,2009,12(48):24~25.

5 李强泽.新型抗精神病药的药物代谢相互作用:比较综述[J].精神相关疾病论坛,2007,1,36~52.

6 刘微波,禹华良,李惠春.奥氮平联合氟西汀治疗精神分裂症阴性症状的对照研究[J].浙江医学,2006,26(4):21~23.

7 王彬,胡峻梅,李宝花.氟西汀合并奥氮平治疗难治性抑郁症对照研究[J].山东精神医学杂志,2006,2(1):12~14.

8 李鹤展,张亚林,张迎黎,等.氟西汀合并奥氮平治疗难治性抑郁症的双盲对照研究[J].山东精神医学,2006,2(1):10~11.

9 马建东,朱性霞,郑华.氟西汀联合奥氮平治疗抑郁症临床疗效对照研究[J].中国民康医学,2004,7(1):4~5.

10 刘发荣,夏玉平,章家新.帕罗西汀合并小剂量奥氮平治疗抑郁症的对照研究[J].上海精神医学,2005,5(1):13~15.

11 刘彩兴,董继承,薛晓斌,等帕罗西汀合并奥氮平治疗伴躯体症状抑郁症的对照研究[J].精神医学杂志,2008,21(3):207~209.

12 李玉焕,高安民,孟祥军.西酞普兰合并奥氮平治疗伴躯体障碍抑郁症的对照研究[J].精神医学杂志,2007,2(1):33~34.

13 余学,赵福涛,刘向阳,等.奥氮平辅助治疗难治性抑郁症患者的疗效及生活质量的影响[J].中国实用医药,2009,25(1):18~19.

14 王传跃,李文标.氟伏沙明抑制奥氮平体内代谢的药代动力学研究[J].中华精神科杂志,2003,36(1):3~6.

15 俞锴,孙轻骑.奥氮平联五氟利多与奥氮平治疗分析[J].中华中西医结合杂志,2006,12(1):48~49.

16 邬德纯,刘永忠,罗来兴.奥氮平合并舒必利治疗难治性精神分裂症的临床对照研究[J].中华行为医学科学杂志,2005,14(7):639.

17 Lemer V, Chudakova B, Kravets S et al Combined use of risperidone and olanzapine in the treatment of patients with resistant schizophrenia: a preliminary case series report[J]. Clin Neuropharmacol 2000, 23(5): 284~286.

18 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DMS-Ⅵ [M]. 4th ed. Washington: American Psychiatric Association, 1994.

19 Mazeh D, Melamed Y, Weizman A. de antagonist augmentation in patients with a partial response to atypical antipsychotics[J]. Can J Psychiatry, 2004, 49(4): 281~282.

20 孙静,牟小冬,李元,等.雷尼替丁防治奥氮平所致体重增加及糖代谢障碍的研究[J].中国神经精神疾病杂志,2007,33(9):560~562.

21 张惠实.奥氮平合并奥硝西洋治疗精神分裂症急性精神运动性兴奋的研究[J].临床精神医学杂志,2007,17(4):239~240.

(收稿:2010-04-06)

简述神经症性障碍的现状与展望

李吉祝 潘淑先 宋丽娜 李盛书 张宪增

【中图分类号】 R749.7 【文献标识码】 A 【文章编号】 1007-3256 (2010) 03-0195-03

神经症性障碍作为一大类疾病,有着复杂的病因学和发病机制,很难用单一的理论模式予以表述。不同类型的神经症,不仅临床表现不同,其致病因素、发病机制、病程、预后以及对治疗的反应也不一致。神经症患者常自觉其精神活动能力受损,产生焦虑和烦恼,或为各种躯体不适感所苦。体格检查不能发现脑器质性病变或躯体疾病作为其临床症状

的基础。自知力大都完好,无持久的精神病症状,通常不会把自己的病态体验与客观现实相混淆,即患者现实检验能力(reality-testing ability)未受损害。行为一般保持在社会规范容许的范围内,可为他人理解和接受。求治欲望迫切,常四处频繁就医。起病多与自身素质、人格特征或精神应激有关。病程多迁延或呈发作性^[1]。本文对其诊治现状简要综述如下:

作者单位:266034 山东省青岛市精神卫生中心

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net